جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : جيهان حسن احمد سليم
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** امبابه **العنوان :** ****
رقم البطاقة : 26609252102364 **رقم التليفون :** 01016264234 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 25-09-1966 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) [14152] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: جيهان حسن احمد سليم
National ID: 26609252102364

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Docetaxel chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DMS
مرحبا
مصطفى



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

NHTMRI

هيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
معهد القومى للكبد والجهاز الهضمى
الأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: جيهان حسن احمد سليم	Age: 60years	Sex: female
Request type: مبادره	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.:288B-2026	
Department:صحه مراه	Date of result:16/5/2026	
Referred by: د/مروه حسن	Date of biopsy:30/4/2026	
Nature of specimen: tru- cut biopsy	I.D. Number:26609252102364	
Clinical diagnosis: right breast mass		

Gross pathology : Multiple gray white tissue cores up to, 1cm long. Totally submitted.
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of mammary tissue show malignant growth formed of files, tubules, nests and cords infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and mild tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. There is focal solid ductal carcinoma insitu of low geade. No lymphovascular invasion or perineural infiltration in core tissue examined.

Immunohistochemical Result;

ER: Strong Positive nuclear staining in 70% of tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Weak nuclear staining of 10% of tumor cells (Allred Score 3/8).
Her2: No membranous staining of tumor cells (Score 0). Negative
Ki67: Positive nuclear staining of 30% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass; tru- cut biopsy:
Invasive mammary carcinoma, grade II

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: جيهان حسن احمد سليم **MR. :** 11060	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

Post-multidisciplinary team discussion, the plan was to place a clip in the right breast lesion and to initiate neoadjuvant chemotherapy with an AC-Taxol regimen.

The patient has a history of hypertension, prior thyroidectomy, and post-menopausal status. She was diagnosed with right-sided breast cancer, clinical stage T2 N1 M0. Pathology showed estrogen receptor positivity (8/8), progesterone receptor positivity (3/8), HER2-negative, and Ki-67 of 30 %. Imaging demonstrated a right upper central mass measuring 26.4 × 26.2 mm, multiple pathological axillary lymph nodes up to 39 × 11 mm, and a few supraclavicular nodes measuring 9.1 × 4.8 mm. Clips were placed at the 12 o'clock position of the right breast. Additional right axillary nodes measured 3 × 2 mm and 3 × 3 mm. The patient's weight is 88 kg, height 155 cm, and body surface area 1.9 m². Neck ultrasound was performed, and laboratory studies were within normal limits.

On examination, a right-sided 12 o'clock mass measured 2 × 2 mm and a right axillary lymph node measured 3 × 2 mm. The patient received cycle 2 of neoadjuvant AC chemotherapy (Adriamycin 114 mg/m², cyclophosphamide 1140 mg) and was given Solu-Cortef and avil before treatment. The patient has completed two cycles of the AC neoadjuvant regimen to date.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

e: Gehan Hasan Ahmed
e:7/4/2026

DIGITALIZED LOW DOSE SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH COMPLEMENTARY BREAST US EXAMINATION OF BOTH BREASTS REVEALED:

- ACR A: Mixed fibro-fatty-glandular breast parenchyma.
- An ill-defined speculated hyperdense lesion is seen at the UOQ of the right breast corresponding by US to an ill-defined globular shaped heterogeneous hypoechoic lesion, vascular is seen at 11 o'clock surrounded by echogenic halo and causing posterior shadowing. It measures 20x12 mm in its max dimensions, (BIRADS V) for biopsy.
- Few enlarged axillary LNs one of them showing increased cortical thickness (4mm) and effaced fatty hilum. The largest measures 18 mm.
- No pathological microcalcification clusters.
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.

Opinion:

- **Right breast UOQ malignant looking lesion associated with ipsilateral axillary lymphadenopathy (BIRADS V); for pathological correlation.**

Much Obliged;
Dr. Marwa Adel,MSc,FEBR

BIRADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

BIRADS 0: *Needs further investigations.*
BIRADS 1: *Normal findings.*
BIRADS 2: *Benign.*
BIRADS 3: *Probably benign.*
BIRADS 4: *Probably malignant.*
BIRADS 5: *Malignant.*
BIRADS 6: *Proven pathologically malignant*

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Medical No. : 3326
Patient's Name: Gihan Hassan Ahmed Selim
Date: 2026-09-26
Referred by: Prof.Dr. **no doctor**
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

REAL TIME NECK ULTRASOUND

- Thyroid gland: [in normal site]

Vague history of right hemithyroidectomy

-The left thyroid gland showing diffusely scattered hypoechoic spongiform multiple nodules variable in sizes largest measuring 7x7mm
-The left lobe measures 1.4 x 1.5 x 4 cm.
-The isthmus measures 0.45 cm in height.
-No retro-sternal extension.
-Central trachea.

- Right enlarged cervical lymph node with preserved fatty hilum (reactionary).

CONCLUSION:

- **Multiple Left thyroid nodules as described (TIRAD 4) for clinical correlation and follow up.**

Best regards,
DR. Sahl Mahmoud

Medical No. : 3326
Patient's Name: Gihan Hassan Ahmed Selim
Date: 2026-09-26
Referred by: Prof.Dr. **no doctor**
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

REAL TIME NECK ULTRASOUND

- Thyroid gland: [in normal site]

Vague history of right hemithyroidectomy

-The left thyroid gland showing diffusely scattered hypoechoic spongiform multiple nodules variable in sizes largest measuring 7x7mm
-The left lobe measures 1.4 x 1.5 x 4 cm.
-The isthmus measures 0.45 cm in height.
-No retro-sternal extension.
-Central trachea.

- Right enlarged cervical lymph node with preserved fatty hilum (reactionary).

CONCLUSION:

- **Multiple Left thyroid nodules as described (TIRAD 4) for clinical correlation and follow up.**

Best regards,
DR. Sahl Mahmoud

Medical No. : 3326
Patient's Name: Gihan Hassan Ahmed Selim
Date: 2026-09-26
Referred by: Prof.Dr. **no doctor**
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

REAL TIME NECK ULTRASOUND

- Thyroid gland: [in normal site]

Vague history of right hemithyroidectomy

-The left thyroid gland showing diffusely scattered hypoechoic spongiform multiple nodules variable in sizes largest measuring 7x7mm
-The left lobe measures 1.4 x 1.5 x 4 cm.
-The isthmus measures 0.45 cm in height.
-No retro-sternal extension.
-Central trachea.

- Right enlarged cervical lymph node with preserved fatty hilum (reactionary).

CONCLUSION:

- **Multiple Left thyroid nodules as described (TIRAD 4) for clinical correlation and follow up.**

Best regards,
DR. Sahl Mahmoud